

DOUGLAS TAKEO ITO - 44a.			
MEDICAMENTOS:	HAS (Losartana)		
SINTOMAS/QUEIXAS	sonolência diurna		
BANHEIRO	1X	P = 102	
HORA QUE ACORDA	6:30	A = 1.80m	
HORA QUE DORME	00:00	IMC = 31.48	
		IAH 81.1/lv	
PRÁTICA EXERCÍCIO	Natação (3x)		
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
02/08	IAH = 81.1/lv		
22	SpO ₂ = 75% min. / SpO ₂ = 91% média. Despertares: 58.8/lv.		
	P = 6cmH ₂ O		
	IAH = 38.1/lv		
	SpO ₂ = 79% min. / SpO ₂ = 94% média		
25/08	P = 5 - 7cmH ₂ O		
22	Início a locação.		
01/09	P = 7cmH ₂ O		
22	IAH = 8.2		
	m. de uso: 6h30' fua		
28/09	P = 7.9cmH ₂ O		
22	IAH = 5.7/lv		
	m. de uso: 6h25' fua		
	sem adaptado		
29/10	P = 8.0cmH ₂ O		
22	IAH = 6.1/lv		
	m. de uso: 6h35'		
27/12	P = 8.0cmH ₂ O		
22	IAH = 4 e/lv		
	m. de uso: 6h48' fua		
	sem adaptado		
28/02	P = 8.0		
23	IAH = 3.8 e/lv sem adapt.		
	m. de uso = 7h14'		
	sem adaptado, relata que está fua		
	havendo fuga de ar.		
05/10	P = 8.0		
23	IAH = 5.0 fua		

28/03
23

$P = 7.7 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\pm \Delta P = 3.8 \text{ e/lv}$

m. de uso: 7hr

Bem adaptado, sem queixas

fua

26/05
23

$P = 6.7 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\pm \Delta P = 2.2 \text{ e/lv}$

m. de uso: 7hr

Bem adaptado

fua

21/07/23

$P = 6.2 \text{ cmH}_2\text{O}$

736 (P90).

$\pm \Delta P = 3.3 \text{ e/lv}$

m de uso: 6h45'

fuga: 4,9 l/min

Bem adaptado.

Auto P: 6 à 8 cmH₂O

sem pa e

29/08
23

$P = 7.0 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\pm \Delta P = 2.6 \text{ e/lv}$

m. de uso: 6h32'

Bem adaptado, s/ queixas.

fua

28/02
24

$P = 8.0 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\pm \Delta P = 6.1 \text{ e/lv}$

m. de uso: 6h5'

Fuga = 44 lpm.

Bem adapt.

Troco o filtro.

fua.

09/05/24

$P = 8.0 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\pm \Delta P = 2.9 \text{ e/lv}$

m. de uso: 6h17m

fuga: 24,5 l/min

Bem adaptado
troco filtro

Natasha

08/08/24

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\pm \Delta P = 3.4 \text{ e/lv}$

m de uso: 6h29m

fuga: 27,7 l/m

Bem adaptado
troco filtro

Reforço higienização

Natasha

10/10/24

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\pm \Delta P = 4.0$

m. de uso = 6h12'

Oriento dormir de lado.

fua.

12/12
24

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$

$\pm \Delta P = 3,4 \text{ e/lv}$

m. de uso: 6hr.

Bem adapt., relata que ã consegue manter
horários.

fua.

10/02/25

P: 8cm H₂O

IAH = 2,5 e/h

med. uso: 5h19'

fuga: 49,8 l/m

Traco fixador p

Natacha

15/04

25

P: 8cm H₂O

faz a locação do aiumini

P: 8cm H₂O

Inicial: 5cm H₂O

Natacha

05/06

2,5

P = 8cm H₂O

IAH = 2,4 e/h

n. de uso = 5h34'

Bem adaptado

30 - 30d.

lua.

Nome: DOUGLAS TAKEO ITO

Data de Nascimento: 4-8-1978

IMC: 31,48

Sexo: Masculino

Data do exame: 06-05-2022

Peso: 102 kg

Altura: 1,80 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 06-05-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 505,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 31,5 e 138,5 minutos. O tempo total de sono foi de 445,5, eficiência de 88,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,5%; estágio N2: 76,7%; estágio N3: 5,6%; sono REM: 16,3%. O índice de despertares foi de 58,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 81,1/hora, sendo elas 79 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 182 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 75%, permanecendo 23,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 97 bpm e NREM de 51 - 99 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 81,1/hora; — 51lv
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=75%); — 97% ate 100%.
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

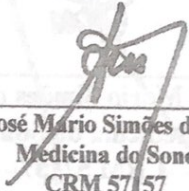
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: DOUGLAS TAKEO ITO

Data de Nascimento: 4-8-1978

IMC: 31,48

Sexo: Masculino

Data do exame: 13-06-2022

Peso: 102 kg

Altura: 1,80 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 13-06-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 453,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 38,0 e 97,0 minutos. O tempo total de sono foi de 343,0, eficiência de 75,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 58,3%; estágio N3: 20,0%; sono REM: 19,5%. O índice de despertares foi de 20,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 33,1/hora, sendo 31 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 158 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 79%, permanecendo 3,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 84 bpm e NREM de 52 - 96 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (08), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco moderado durante o sono.

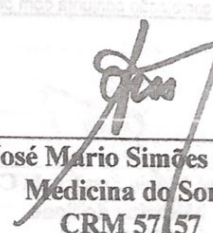
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157